

УДК 618.19-006.6

Д.К. Алдынгуров А.С. Аубакирова С.Т. Олжаев
ГКП на ПХВ Алматинский региональный онкологический диспансер

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЬШИМ САЛЬНИКОМ КАК МЕТОД ВЫБОРА

Аннотация. Органосохраняющие операции стали неотъемлемой частью в комплексном лечении больных раком молочной железы в ранней стадии и в течение многих лет доказали эстетичность, безопасность и целесообразность.

Было доказано, что сочетание органосохраняющей операции и лучевой терапии аналогично по своей эффективности мастэктомии. В погоне за совершенствованием методов реконструкции, которые преследуют цель-получение высокого эстетического результата, менее травматичность операции, уменьшение количества осложнений были выработаны новые виды операций.

Одна из которых называется- подкожная мастэктомия с сохранением сосково-ареолярного комплекса с возмещением ложа удаленной молочной железы большим сальником, обработанного лапароскопическим методом с сохранением сосудистой ножки, с выведением подкожно в подреберье с соответствующей стороны и выведение в ложе удаленной молочной железы через подкожный туннель. Этот метод не только удовлетворяет всем онкологическим принципам, которые требуются при выполнении радикальных операций но и сокращает объем лимфореи в послеоперационном периоде за счет абсорбционной способности самого сальника, и при этом имеет необходимый косметический эффект.

Ключевые слова: раком молочной железы, мастэктомия Органосохраняющие операции, эстетичность.

Введение. Более столетия прошло с того момента как хирурги начали совершенствовать методы лечения рака молочной железы (РМЖ). Специалисты из стран Америки и Канады начали внедрять органосохраняющие резекции с последующим облучением оставшейся части молочной железы. В исследованиях сравнивались данные выживаемости при органосохраняющих операциях и мастэктомиях. Статистика показало одинаковую выживаемость [2].

США и Канада первыми внедрились безмастэктомический метод лечения РМЖ. В 1975г были опубликованы первые данные исследования из Йельского университета, и работы Weberi Hellman из Бостанского университета. В исследованиях было отмечено что женщины, которые выбрали в качестве лечебной тактики органосохраняющую операцию, «не заплатили безопасностью по сравнению с мастэктомией» Эти данные были столь убедительны, что в 1990 году конференция, методом выбора лечения рака молочной железы ранней стадии утвердило органосохраняющую операцию (breastparing). Которая дает возможность сохранить целостность организма и при этом дает менее травматичный хирургический эффект [3].

Важным принципом выполнения радикальности данного метода было соблюдение «чистоты краев» резецированного участка. Однако даже после резекции позитивный ответ может быть в не более 50% случаев и поэтому не было необходимости широко отступать от краев опухоли для получения абсолютно чистых краев. Авторы приводят данные, что достаточно отступить 3-10 мм от опухоли [4,5].

Много данных крупных международных исследований, где частота местных рецидивов после органосохраняющих операции может достигать до 40%. Но, при сочетании с лучевой терапией число местных рецидивов не превышает 15%. Конечно сама лучевая терапия несет с собой ряд осложнений, однако это компенсируется психологическим удовлетворением женщины от сохраненной груди[2]. В связи с эффективностью проводимых скрининговых программ направленных на раннее выявление рака молочной железы, количество органосохраняющих операций стало преобладать над мастэктомией.

FisherB. (1976), в своей теории развития рака молочной железы, описывает, что даже выявленная на ранних этапах опухоль не исключает наличия отдаленных, скрытых метастазов [2]. Подтверждением этому факту является то, что основной причиной смерти у больных РМЖ является отдаленное метастазирование, а не местный рецидив. В то же время доказано, что удаление подмышечных лимфоузлов не является лечебной, а лишь диагностической манипуляцией, потому что в 5% случаев причиной отдаленного метастазирования является лимфоидная ткань. В исследованиях доказано что у больных с минимальной опухолью частота пораженных лимфоузлов коррелируется с размером опухоли. То есть при минимальном размере опухоли в удаленных лимфоузлах метастазы не обнаруживаются [5]. Таким образом, в целях улучшения качества жизни онкологических пациентов, в поисках в наиболее оптимального решения, которое в себе сочетало бы все онкологические принципы и понимание целостности органа, привело к развитию онкопластической хирургии. Онкопластика не пренебрегает основным принципам онкологии для выполнения не только щадящего лечения, но и сохранение груди в том виде, который ненамного отличал бы железу от исходного варианта [2].

На сегодняшний день органосохраняющие операции выполняются в разных его модификациях: квадрантэктомия, лампэктомия, но большим прогрессом явилось внедрение в хирургическую практику органосохраняющих операции, основанных на простом возмещении объема. Современные требования к органосохраняющим операциям заключаются в получении оптимального косме-

тического эффекта, а эти результаты достигаются только с внедрением пластического компонента к стандартным органосохраняющим операциям [2].

Подкожная мастэктомия с сохранением сосково-ареоларного комплекса с возмещением объема собственной тканью дало нам рассмотреть несколько вариантов реконструкции молочных желез где предлагаются варианты замещения TRAM-лоскутом, мышечно-жировым лоскутом из широчайшей мышцы спины. Но при выборе данных методов возмещения, лоскут лишен дистального кровотока что дает высокий риск осложнения в виде краевого некроза с последующим отторжением или даже с вторичным инфицированием.

Методика возмещения ткани подкожно удаленной молочной железы большим сальником, который обрабатывается лапароскопическим методом с сохранением питательной ножки с предварительной деиннервацией, которая выводится в области подреберья с соответствующей стороны и выводится в ложе молочной железы с укреплением на большой грудной мышце отдельными швами, придавая форму исходной молочной железы. Благодаря богатой сети кровеносных и лимфатических сосудов большой сальник обладает способностью рассасывания экссудата, отечной жидкости и даже высокомолекулярных соединений. Поэтому его можно успешно использовать для борьбы с инфекциями, в целях «биологического иссечения» некротизированных тканей, реваскуляризации ишемических тканей; он также служит прекрасной основой для реваскуляризации кожи при ее свободной пересадке. Идея использования большого сальника принадлежит Drummond и Morrison (1986), которые для отвода асцитической жидкости рекомендовали создавать шунт между портальными сосудами и сосудами сальника. Для возмещения обширных дефектов кожи молочной железы и окружающей области большой сальник впервые использовал в 1963 году Kircuta. Этот метод широко распространился, особенно для замещения обширных дефектов кожи, возникших после иссечения пораженных участков и лучевых язв, образовавшихся в результате комбинированного лечения (операция + облучение) рака молочной железы [7].

Цель работы - Провести оценку эффективности результатов данного метода в сравнении с традиционными методами пластики молочной железы.

Внедрить в клиническую практику данный метод реконструкции который дает хороший косметический эффект, сокращает длительность лимфореи в послеоперационном периоде, отсутствуют осложнения, связанные с недостаточным кровоснабжением.

Материал и методы. С 2013 по 2016 год было выполнено 12 органосохраняющих операций с восполнением ложа удаленной железы большим сальником.

В наблюдении были 10 женщин с диагнозом рак молочной железы T1-2 N1-0 M0, где опухоль не прорастала в дерму, локализация по квадрантам не учитывалась. Медиана наблюдения 2,5 года. У одной пациентки через 1,2 года был выявлен рак *insitu* в противоположенной груди. Пациентка была прооперирована, проведено подкожная мастэктомия, по желанию пациентки с реконструкцией имплантом. Все больные получили комплексное лечение в после операционном периоде, также женщины с гормо-

нопозитивной формой в течение последующих лет находились на гормонотерапии.

Возмещение большим сальником обладает рядом преимуществ в отношении эстетических результатов реконструкции и степени хирургической морбидности:

- снижает длительность лимфореи за счет абсорбирующей способности большого сальника. Особые показания данный метод имеет при положительном статусе ЭР и ПР, при котором показана одновременная лапароскопическая овариоэктомия;

- методика выделения и перемещения большого сальника довольно проста при владении эндовидеохирургией, восстановительный период для пациентки сокращается;

- хорошая васкуляризация большого сальника снижает процент осложнений.

Богатая сосудистая сеть сальника позволяет мобилизовать не только одну его половину, но и значительно удлинять изолированную часть при максимальном обеспечении хорошего кровоснабжения. Kircuta (1963) считает, что сальник может быть перенесен на грудную стенку вообще без мобилизации. Das (1976) на основании измерений, выполненных на 200 трупах и 100 пациентах в ходе лапаротомии, определил среднюю длину большого сальника в 25 см, его среднюю ширину в 33 см (у женщин эти размеры на 1—2 см меньше). Kircuta с точки зрения мобилизации считает обе желудочно-сальниковые артерии равноценными, а другие специалисты отдают предпочтение правой желудочно-сальниковой артерии. Левая артерия располагается выше, а в 19% случаев вообще отсутствует (Anson и Lyman, 1936). Adlay и Goldsmith (1972), а также Das (1976) разработали различные варианты для обширной мобилизации сальника, соответствующие вариантам прохождения артерий сальника и связывающей их сосудистой сети.

Методика возмещения удаленной молочной железы большим сальником является радикальной операцией при небольших размерах первичной опухоли и обеспечивает сравнимую со стандартной методикой без рецидивную выживаемость. Использование данной методики оперативного лечения должно быть строго индивидуализировано. Критериями отбора пациентов для проведения указанного оперативного лечения является:

- операбельный рак молочной железы категории T1-0 N0-1 M0;

- железы размерами А-С;

- желание пациентки сохранить молочную железу [3,6].

Результаты и обсуждение. С внедрением подкожной мастэктомии с сохранением сосково-ареоларного комплекса с одномоментной реконструкцией большим сальником мобилизованного лапароскопическим методом, улучшились показатели проводимых пластических операций на молочной железе проводимые в нашей клинике. Пациенты на второй день активны, выписываются на 5-6 сутки. Отличный косметический эффект. Все пациенты наблюдаются каждые 3 месяца, проходя комплекс диагностических исследований для контроля отдаленных метастазов и местного рецидивирования. Самый главный аспект это качество жизни.

Заключение. На сегодняшний день реконструктивно-

пластические операции прочно обосновались в онкологической структуре как безопасный вариант лечения ран-

них формам рака молочной железы для удовлетворения психо-социальных потребностей пациентов.

Список литературы

1. Alderman A.K., Kuhn L.E., Lowery J.C., Wilkins E.G. Does patient satisfaction with breast reconstruction change over time? Two year results of the Michigan Breast Reconstruction.- 2007.
2. Bailldam A.D. Oncoplastic surgery for breast cancer.- 2008.
3. Munhoz A.M., Albright C., Ferreira M.C. Paradigms in oncoplastic breast surgery: a careful assessment of the oncological need and aesthetic objective.- 2007.
4. Rezai M., Veronesi U. Oncoplastic principles in breast surgery.- 2007.
5. Rietjens M., Urban C.A. Long-term oncological results of breast conservative deformity, 2004.
6. Slavin S.A., Halperin T. Reconstruction of the breast conservation deformity.- 2004.
7. <http://medbe.ru/materials/plastika-grudi/ispolzovanie-salnika-dlya-rekonstruktsii-molochnoy-zhelezy/>.
8. Исмагилов А.Х., Хасанов Р.Ш., Губайдуллин Х.М., Ванесян А.С. Реконструкция молочной железы с использованием эндопротезов. Алгоритм выбора // Медицина молочной железы // II Междисциплинарный форум Holiday Inn Moscow Sokolniki.-2012.-С. 26-27.
9. Летягин В.П., Григорьева Т.А. Реконструктивно-пластические операции в лечении больных раком молочной железы // Опухоли женской репродуктивной системы. -2012.-№2.-С.19-26 2012.

ТУЖЫРЫМ

Д.К. Алдынгуров А.С. Аубакирова С.Т. Олжаев
ГКП на ПХВ Алматинский региональный онкологический диспансер

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЬШИМ САЛЬНИКОМ КАК МЕТОД ВЫБОРА

Қазіргі таңда, ағзаны сақтауға бағытталған оталар, сүт безінің обырын ерте сатысында отамен емдеу кешенінің ажырамас бөлігі болып қалыптасты. Ол қазіргі заманның эстетикалық, қауіпсіздік талаптарына сай келеді.

Ағзаны сақтауға бағытталған отаны толықтырған сәулелік емнің маңыздылығы, мастэктомияға тең. Ағзаны сақтау ота әдістерін жетілдіруде жоғары эстетикалық нәтиже, аз жарақат алуды мақсатында- емізікпен ареола аймағын сақтап қалу радикальді тері асты мастэктомиясынан кейін, сүт безінің орынын лапароскопиялық турмен өңделген үлкен шарбы майымен толықтыру түрі әдістелді.

Бұл әдіс барлық онкологиялық принциптердің талабына сай келеді. Отадан кейінгі тәулікте өзінің сорғыштық қасиетінің арқасында лимфорея көлемін қысқартады және талап етілген косметикалық әсер береді.

Ключевые слова: раком молочной железы, мастэктомия Органосохраняющие операции, эстетичность

SUMMARY

D.K.Aldyngurov, A.S.Aubakirova, S.T.Olzhayev
Almaty Regional Oncology Center

Reconstruction of the breast with large seal as the method of selection in patients with breast cancer

Organ-sparing surgery has become an integral part in the treatment of patients with breast cancer at an early stage and for many years has proved the aesthetics, safety and appropriateness.

Been shown that the combination conserving surgery and radiation therapy was similar in effectiveness to mastectomy. In pursuit of the improvement of selection methods given a more aesthetic result, for less traumatic volume operation, reduce the number of cases of the complication have been developed new types of operations, one of which is called subcutaneous mastectomy with preservation of nipple-areola complex and replacement of greater omentum treated laparoscopically with preservation of the vascular pedicle, with the removal of the quadrant with the appropriate parties subcutaneously and bred in the bed of the mammary gland through the subcutaneous tunnel created in advance by coagulation.

This method not only satisfies all oncological principle which are required when performing radical surgery but also reduces oblem limpera in the postoperative period due to the absorption capacity of the gland itself but also gives an excellent cosmetic effect.

Key words: breast cancer, mastectomy, Breast- conserving surgery, aesthetics



ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
РАКА ГОЛОВЫ И ШЕИ

С 19 по 23 сентября 2016 года по эгидой Европейской ассоциации онкологов в городах:

Алматы

Астана

Усть-Каменогорск

Караганда

пройдет неделя **ранней диагностики рака** головы и шеи!
Вы имеете возможность пройти **БЕСПЛАТНЫЙ** осмотр у специалистов мультидисциплинарной группы (онколог, отоларинголог и стоматолог).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ЕСЛИ ХОТЯ БЫ **ОДИН** ИЗ ЭТИХ СИМПТОМОВ СОХРАНЯЕТСЯ БОЛЕЕ **ТРЕХ** НЕДЕЛЬ



ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ!

РАННЕЕ ОБРАЩЕНИЕ К СПЕЦИАЛИСТУ И РАННЯЯ ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА СПАСАЮТ ЖИЗНЬ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ!

СЕНТЯБРЬ С 19 по 23 сентября 2016

Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Записаться на приём Вы можете по телефону бесплатной горячей линии:

8 800 080 5058

VIVA Pharm

MERCK

ERBITUX®
CETUXIMAB

Вы увидите разницу

Персонализированная терапия оптимизирует клинические исходы

- Тестирование на наличие мутаций RAS (KRAS и NRAS) является ключевой стратегией для выбора оптимальной терапии первой линии для лечения метастатического колоректального рака (мКРР)¹⁻⁶
- Добавление Эрбитукса к стандартной химиотерапии позволяет существенно увеличить общую выживаемость на 8.2 месяца¹ у пациентов с мКРР с «диким» типом RAS *
- Эрбитукс является единственным ингибитором EGFR, одобренным к применению в комбинации с FOLFOX и FOLFIRI в 1 линии терапии мКРР, показавшим увеличение общей выживаемости более, чем на 32 месяца³⁻⁴

* FIRE-3 исследование: Первичная конечная точка ОО у пациентов с мКРРс KRAS (exon 2) wt. не была достигнута

2016-AANA-ADAAMS_ ITC-ONC-Erb-MDL-02.SEP.2016

Эрбитукс®. Краткая инструкция по медицинскому применению

Торговое название: Эрбитукс®

Международное непатентованное название: Цетуксимаб.

Лекарственная форма: Раствор для инфузий 5мг/мл

Фармакотерапевтическая группа: Противоопухолевые препараты. Противоопухолевые препараты другие. Моноклональные антитела. Цетуксимаб. Код АТХ L01XC06.

Показания к применению: метастазирующий колоректальный рак, экспрессирующий рецепторы эпидермального фактора роста (EGFR) и RAS дикого типа; в комбинации с химиотерапией на основе иринотекана; в качестве терапии первой линии в комбинации с режимом FOLFOX4; в качестве монотерапии в случае неэффективности предшествующей химиотерапии на основе иринотекана и оксалиплатина, а также при непереносимости иринотекана; плоскоклеточный рак органов головы и шеи; в комбинации с лучевой терапией при местнораспространенном процессе в комбинации с химиотерапией на основе препаратов платины – при рецидивирующей и/или метастазирующей опухоли.

Противопоказания: Эрбитукс® противопоказан пациентам, у которых отмечались тяжелые реакции гиперчувствительности на цетуксимаб 3-4 степени (классификация Национального Института Рака США (Общие критерии токсичности для нежелательных явлений (CTCAE)); применение препарата Эрбитукс® в комбинации с оксалиплатин-содержащей химиотерапией у пациентов с метастазирующим колоректальным раком (мКРР) с мутантным типом генов RAS с неизвестным статусом генов RAS противопоказано; беременность и период лактации исключают применение препарата Эрбитукс®; детский и подростковый возраст до 18 лет (безопасность применения не установлена).

Способ применения и дозы: Эрбитукс® вводится внутривенно с максимальной скоростью инфузии не более 10 мг/мин. Перед первой инфузией препарата пациенты должны получить премедикацию антигистаминными средствами и кортикостероидными препаратами не менее, чем за 1 час до введения цетуксимаба. Премедикация рекомендуется также при всех последующих инфузиях. При всех показаниях Эрбитукс® вводится 1 раз в неделю. Начальная доза препарата составляет 400 мг цетуксимаба на 1 м² площади поверхности тела. Все последующие еженедельные дозы составляют 250 мг цетуксимаба на 1 м². Начальная доза вводится медленно, и скорость инфузии не должна превышать 5 мг/мин. Длительность первой инфузии препарата – не менее 120 минут. В последующем продолжительность еженедельных введений – до 60 минут. Скорость инфузии не должна превышать 10 мг/мин.

Побочные действия: Очень часто (>1/10): кожные реакции главным образом, представленные как акнеподобная сыпь, прурит, сухость кожи, шелушение, гипертрихоз, паронихия; гипомагнемия; повышение активности печеночных ферментов (АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы); умеренные или средние инфузионные реакции (лихорадка, озноб, головокружение, диспноэ, которые случаются в тесной временной взаимосвязи, главным образом, по отношению к первой инфузии Эрбитукса®); мукозит, в некоторых случаях тяжелый. Мукозит может привести к эпистаксису. Часто (от >1/100 до <1/10): головная боль; тошнота, рвота, диарея; конъюнктивиты; тяжелые инфузионные реакции, в редких случаях с летальным исходом; анорексия, которая может привести к уменьшению веса; утомляемость; дегидратация, в связи с вторичной диареей или мукозитом, гипокальциемия. Редко (от > 1/1000 до <1/100): блефариты, кератиты; легочная эмболия, интерстициальное заболевание легких; тромбоз глубоких вен. Очень редко (< 1/10,000): синдром Стивенса-

Джонсона/токсический эпидермальный некролиз. Частота неизвестна: асептический менингит; суперинфекция поражений кожи, которые могут привести к последующим осложнениям, т.е. целлюлит, рожистому воспалению, или, потенциально с фатальным исходом, стафилококковому ожогоподобному синдрому или сепсису. **Особые указания:** Эрбитукс® должен вводиться под наблюдением врача, имеющего опыт применения противоопухолевых лекарственных средств. В процессе инфузии и в течение по крайней мере 1 часа после ее завершения следует проводить тщательный мониторинг пациентов. Необходимо наличие оборудования, требующегося для проведения реанимационных мероприятий. *Инфузионные реакции, включая анафилактические реакции.* У пациентов на фоне лечения цетуксимабом могут возникать тяжелые инфузионные реакции, в том числе анафилактические реакции, в редких случаях с летальным исходом. Развитие тяжелой инфузионной реакции требует немедленной и полной отмены цетуксимаба, а также может потребовать проведения реанимационных мероприятий. Некоторые из этих реакций могут быть анафилактическими или анафилактоидными по природе или представлять собой синдром высвобождения цитокинов (СВЦ). Симптомы могут появиться во время первой инфузии и длиться до нескольких часов после или во время последующих инфузий. Рекомендуется информировать пациентов о возможности отсроченного развития таких реакций и инструктировать их о необходимости обратиться к врачу при развитии симптомов инфузионных реакций. Симптомы могут включать бронхоспазм, крапивницу, повышение или снижение артериального давления, потерю сознания. В редких случаях наблюдались стенокардия, инфаркт миокарда или остановка сердца. Анафилактические реакции могут развиваться уже в течение нескольких минут при первой инфузии, например, в связи с ранее сформированными антителами IgE (иммуноглобулин Е), дающими перекрестную реакцию с цетуксимабом. Эти реакции обычно связаны с бронхоспазмом и крапивницей и могут возникать, несмотря на введение премедикации. **Передозировка:** В настоящее время существует ограниченный опыт применения однократных доз, превышающих 400 мг/м² площади поверхности тела или еженедельного применения доз, превышающих 250 мг/м² площади поверхности тела.

Производитель: Мерк КГаА, 64293 Дармштадт, Германия

Владелец регистрационного удостоверения: Мерк КГаА, 64293 Дармштадт, Германия

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)

ТОО «ВИВА Фарм», ул. 2-я Остроумова, 33, г. Алматы, РК.

Тел.: +7 (727) 383 74 63, +7 (727) 311 00 42

Факс: +7 (727) 383 74 56

E-mail: PV@vivapharm.kz

1. Van Cutsem E et al. J Clin Oncol 2015;33:692–700.

2. Heinemann V et al. Lancet Oncol 2014;15:1065–1075.

3. Stintzing Set al. ESMO 2014 (Abstract no. LBA11), updated information presented at meeting.

4. Lenz H-J et al. ESMO 2014 (Abstract no. 5010), updated information presented at meeting.

5. Van Cutsem E et al. Ann Oncol 2014;25(suppl 3):iii1–iii9.

6. NCCN Colon Cancer Guidelines Version 2.2015 available at:

http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp Last accessed July 2015.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

VIVA Pharm

MERCK